Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2026-2027

CORRECTION

Examen Blanc n°1 PASS

UE 7 : SHS



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 7 pages numérotées de 1 à 7 et comporte 2 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Mot de votre RM :

BIEN LE BONJOUR LES SHStars

Avant tout, je tiens à vous **féliciter** pour deux choses :

- **Bravo** d'être venu à ce premier tuto de SHS, on sait que cette matière peut être un peu intimidante au départ, avec un format d'épreuve très différent de toutes les autres **(c'est ce qui fait son charme hihi)**. C'est justement parce que cette matière est rédactionnelle qu'il faut **s'entraîner un max** ! (Si vous n'avez pas pu venir au tuto, c'est tout à fait ok, n'hésitez pas à essayer de faire le sujet chez vous)
- **Bravo** d'avoir ouvert cette correction : ici c'est la correction générale, mais vous aurez, une fois vos copies corigées, accès à une **correction spécifique à chacun d'entre vous** ! C'est la seule matière où vous aurez des retours aussi précis sur vos travaux, alors **profitez en** ! Cela vous permettra de cibler vos points faibles ET vos points forts, mais surtout d'avoir un retour sur votre méthodo **(je ne le rappelerai jamais assez mais la méthodo est cruciale en SHS, et la respecter permet de gagner BEAUCOUP de points)**. Les différents tutos de SHS vous permettront à chaque fois un peu + de cibler les attendus du jour J.

Il est vraiment important de **ne pas vous focaliser** sur votre note, mais plutôt sur le fond de la correction, sur les petits bouts de **raisonnement** qu'il pourraît vous manquer. Sur un ton un peu moins sérieux, j'espère que vous vous octroyez des **pauses** aussi souvent qu'il vous en faut (c'est very important), n'**oubliez jamais** que nous sommes là si vous avez besoin de parler/pleurer/rire un peu (même beaucoup) !
Je vous laisse avec cette correction, concoctée avec **beaucoup de soin et de love** !
Gabrielle, votre **RM** qui vous **E**nvoie beaucoup de **B**onnes vibes

QROC :

Dans quel contexte la bioéthique a-t-elle émergé aux Etats-Unis et en France ?(10 lignes)

QROC

L'émergence de la bioéthique s'inscrit dans un contexte social particulièrement favorable. En France comme aux Etats-Unis, cette période est marquée par un recul des religions, un pluralisme social (coexistence de diverses valeurs morales), l'émergence de la valeur de l'autonomie, et la montée de revendications sociales (comme la lutte pour l'égalité des races et des sexes, la liberté sexuelle, etc.). En parallèle, la vision des sciences évolue sous la révélation de scandales sanitaires majeurs comme la mise sur le marché de médicaments toxiques (thalidomide) ou d'expérimentations criminelles (Tuskegee). Certaines innovations dans les pratiques médicales, comme la réanimation, ouvrent également la discussion sur des questions éthiques. Ces dérives suscitent alors une vague de critiques remettant en question la science, mais aussi la profession médicale et la médecine.

Commentaire de texte :

Cette partie est à rédiger sur la copie commentaire de texte, dans l'encart prévu. Merci de ne pas rédiger vos réponses au feutre, ce qui rend la copie quasi impossible à lire et donc à corriger.

Le contrôle sanitaire des médicaments est ancien puisque des auteurs en soulignent la présence dès l'Antiquité. Mais il reste pendant longtemps surtout centré sur la vérification de la qualité des produits (composition, mode de préparation, présence ou non d'impuretés, etc.), grâce par exemple à des inspections chez les apothicaires qui ont la charge de réaliser et de vendre les traitements ou à la rédaction de pharmacopées. Le principe d'une autorisation préalable par les pouvoirs publics de chaque traitement commercialisé, basée sur une évaluation scientifique de ses effets, s'est affirmée beaucoup plus récemment. Les crises sanitaires, l'industrialisation de la production des médicaments, la mise au point de produits plus puissants à partir des années 1930, le développement des savoirs scientifiques, contribuent au développement de ce contrôle au cours du xxe siècle. [...]

À la différence du Royaume-Uni ou de l'Allemagne, la France a par exemple instauré un système de visa pour les nouveaux médicaments en 1941 – même si ce visa répond à de multiples objectifs, notamment protectionnistes*, et si les données demandées comme leur examen par l'administration restent limités. [...] Au cours des années 1960 – qui sont marquées par le retrait mondial du Thalidomide en 1961, après qu'il eut fait plusieurs milliers de victimes – l'idée d'une décision de mise sur le marché traduisant un jugement porté à la fois sur les bénéfices et les risques des produits est affirmée dans plusieurs importantes législations. [...] Puis, au cours des années 1970, l'essai clinique randomisé – qui permet la mesure statistique des propriétés d'un médicament en comparant ses effets à ceux d'un placebo ou d'un produit concurrent – s'imposera comme l'instrument de référence pour l'évaluation de cette balance « bénéfice risque ». [...] En France, le système du visa est réformé en 1959 et en 1967 une commission d'autorisation de mise sur le marché (AMM) des médicaments est instaurée.

Boris Huaray, Propos recueillis par Hélène Michel.
« L'évaluation des médicaments, un enjeu politique », *Savoir/Agir 2011/2 n° 16 , p. 31-36*

*Qui se rapporte au protectionnisme, doctrine économique dont le but est de favoriser l'économie nationale par la limitation de l'entrée de produits étrangers.

Consigne : En vous appuyant sur vos connaissances et sur le texte, vous montrerez en quoi consiste le contrôle traditionnel des médicaments jusque dans les années 1930, et quelles en sont ses limites. Vous expliquerez comment l'auteur décrit ensuite la construction progressive d'un contrôle moderne scientifique et rigoureux reposant notamment sur l'essai clinique randomisé.

Propos introductif

Le texte proposé fait référence au CM1 sur « De la recherche à la commercialisation du médicament : enjeux éthiques et sociaux ». Le texte fait particulièrement référence au contrôle du médicament, et à l'évolution de ce dernier dans le temps. C'est un texte qui a une trame très chronologique, un peu comme votre cours, donc il apparaît assez instinctif de suivre la chronologie pour créer son plan. Pour autant, trouver la limite entre les deux parties peut ne pas être toujours évident. Nous entamerons une première partie qui portera sur l'évolution du contrôle des médicaments de l'Antiquité jusqu'aux années 1930, avec les nombreuses évolutions de la profession de pharmacien, les différentes tentatives de contrôle des pratiques et des médicaments. Nous commencerons ensuite la deuxième partie, avec la loi de 1941 qui est une phase de transition, un premier pas vers une démarche scientifique, et qui ouvre la voie vers les essais cliniques randomisés.

Cela peut être un peu difficile de ne pas s'éparpiller au départ, mais l'important est de toujours garder un lien fort entre connaissances et texte, c'est cela même l'essence du commentaire en SHS.

Correction du commentaire

Le texte proposé à notre étude est extrait dun article intitulé : « L'évaluation des médicaments, un enjeu politique », issu de la revue Savoir/Agir, qui relate des propos tenus par Boris Huaray, recueillis par Hélène Michel en 2011.
Il s'agit d'un texte à visée sociologique et historique, dans la mesure où il retrace l'ensemble des évolutions des dispositifs de régulation pharmaceutique depuis l'Antiquité jusqu'au XXème siècle incluant également les problématiques sociologiques de chaque époque. Son thème principal porte donc sur la transformation progressive du contrôle des médicaments à travers les époques.
L'auteur inscrit son texte dans un contexte historique marqué par des évolutions constantes de la production pharmaceutique, avec notamment, de profonds changements au XXème siècle, comme l'industrialisation de la production et l'essor de scandales sanitaires, qui ont révélé les limites des dispositifs existants. Le XXème siècle voit émerger un modèle radicalement différent, fondé sur l'expérience scientifique et l'évaluation statistique.
Ainsi, l'auteur se demande comment le contrôle des médicaments est passé d'un modèle traditionnel, fondé sur des pratiques empiriques, à un modèle moderne reposant sur l'évaluation scientifique du rapport bénéfice/risque.
Selon l'auteur, les différents événements survenus au cours du XXème siècle ont profondément impacté l'ensemble du domaine pharmaceutique, et ont permis de passer de méthodes empiriques et peu sûres à des méthodes modernes qui s'appuient sur des fondements scientifiques plus certains.

Le texte évoque dans un premier temps une notion importante, celle du contrôle des médicaments : celui-ci est très ancien. En effet, "des auteurs en soulignent la présence dès l'Antiquité" (l.1-2). La diffusion des savoirs pharmaceutiques est une histoire de longue durée, dont des preuves remontent à plusieurs siècles avant J-C, notamment en Mésopotamie, et plus tard, en Grèce Antique. Pour autant, le contrôle de la fabrication des médicaments à l'époque est "centré sur la vérification de la qualité des produits" (l.2-3). C'est-à-dire que les médicaments sont contrôlés sur leur "composition", leur "mode de préparation" (l.3), et non pas sur leurs effets thérapeutiques, ou délétères. Par la suite, au Moyen-âge, apparaissent les "apothicaires" (l.4), qui sont les ancêtres des pharmaciens, ils sont "en charge de réaliser et de vendre les traitements" (l.4-5). Il existe, dès le XVème siècle, une volonté d'encadrer

leurs pratiques et leurs fabrications. Charles VIII réunira les épiciers et les apothicaires en une seule corporation afin d'encadrer au mieux leurs pratiques. Le texte évoque également des "inspections chez les apothicaires" (l.4). Les apothicaires ont vu leur pratique de plus en plus encadrée par certaines réglementations étatiques au cours du temps, suite auxquelles ils pouvaient être inspectés. Par exemple, la fin du XVIIème siècle est marquée par le constat de l'ambivalence des traitements : les médicaments soignent, mais ont également le pouvoir de tuer. Certaines substances, comme l'arsenic sont mortelles à forte dose. Ce constat pousse à augmenter encore le contrôle et les inspections chez les apothicaires, notamment suite au décret de Louis XVI en 1777, qui implique le Lieutenant de Police, représentant du roi, dans le contrôle des substances dangereuses. Ce contrôle est donc plus rigoureux, bien que les substances considérées comme dangereuses soient peu nombreuses, et que certains remèdes qui représentent un danger soient encore vendus librement, sans contrôle.
Le texte mentionne également l'existence de "pharmacopées" (l.5), dont les apothicaires sont chargés de la rédaction. On peut les définir comme étant des recueils donnant la liste des remèdes avec leur origine, leur mode de préparation et leurs effets. Ces pharmacopées représentent un atout dans le contrôle des médicaments, puisqu'elles permettent de déterminer avec plus de rigueur ce que les pharmaciens peuvent vendre et préparer, avec quels produits, et de quelle façon. Cela permet de lutter contre le charlatanisme, en évitant la vente de remèdes "miracles". Pour autant, ici encore, on cherche à éviter les remèdes qui n'ont pas d'effets, mais on ne se penche pas encore réellement sur ceux qui pourraient avoir des effets dangereux.
Il existe au début du XXème siècle une phase de transition marquée par de nombreux évènements, dont, des "crises sanitaires" (la thalidomide, que nous reverrons ensuite) (l.7-8), "la mise au point de produits plus puissants" (quinine) (l.8-9). Aussi, on assiste à l'essor des spécialités, permis par la chimie organique et de synthèse, développée fin XIXème. S'instaure alors une "industrialisation de la production des médicaments" (l.7). Les spécialités sont des médicaments « prêts à l'emploi », que le pharmacien n'a plus qu'à stocker et distribuer en fonction des ordonnances qui lui sont présentées. Cette industrialisation modifie profondément le modèle économique de l'industrie pharmaceutique. Ainsi, les contrôles préexistants ne correspondent plus au nouveau modèle de production. Jusqu'au XIXème siècle, le pharmacien est seul garant de la qualité de ses produits. L'industrialisation ne permet plus un tel modèle, les médicaments échappent à un contrôle, pourtant nécessaire.

Les années 1940 peuvent être considérées comme des années charnières vers une réelle prise de conscience de la nécessité d'un contrôle rigoureux et soutenu par les pouvoirs publics. En effet, elles sont marquées par "le développement des savoirs scientifiques" (l.9). Ce développement permet de créer une loi qui marque le premier pas vers une scientifisation du contrôle des produits. La France a été un des premiers pays a avoir instauré un "système de visa pour les nouveaux médicaments en 1941" (l.12). On évoque ici la loi du 11 septembre 1941, qui remplace la loi du 21 Germinal an XI. Cette loi entraîne un contrôle plus rigoureux de la fabrication, et instaure donc un système de "visa" (l.12), octroyé par le ministre de la Santé Publique sur proposition du comité technique des spécialités (CTS), constitué de professeurs et de scientifiques. Il s'agit donc d'un réel progrès. Pour autant, le texte évoque le fait que ce visa répond à des objectifs "protectionnistes" (l.13), c'est-à-dire une protection économique des médicaments français face aux grandes firmes étrangères, comme Bayer. C'est une mesure qui augmente la concurrence entre les différentes firmes pharmaceutiques. Ainsi, l'objectif principal ici n'est pas la protection de la santé, mais plutôt, celle du maintien de la prospérité économique du domaine pharmaceutique. De plus, "Les données demandées comme leur examen par l'administration restent limités"(l.13-14).
Le véritable tournant s'opère dans les années 60, notamment suite au scandale sanitaire du "Thalidomide" (l.15), qui a provoqué de graves malformations congénitales auprès de

"plusieurs milliers de victimes" (l.15), suite à la prise du médicament par des femmes enceintes. Ce scandale est un catalyseur vers un contrôle plus rigoureux, se basant sur des faits scientifiques. Le texte évoque également un "jugement porté à la fois sur les bénéfices et les risques des produits"(l.16-17). Une idée importante émerge alors : le danger potentiel représenté par le médicament doit être bien plus pris en compte. Il faut ainsi que le bénéfice soit supérieur au risque potentiel. On appelle cela la balance bénéfice-risque favorable. Cette dernière notion représente un pilier central de l'"autorisation de mise sur le marché (AMM) des médicaments" (l.22), mise en place dans les années 1960.
C'est dans ce contexte qu'est diffusé, "au cours des années 1970, l'essai clinique randomisé" (l.18). Ce dernier est proposé par les chercheurs dans les années 50, mais sans réelle adhésion par les médecins. Le Thalidomide a permis de légitimer ce modèle. L'essai clinique randomisé peut être considéré comme une vraie démarche scientifique. Il inclut de nombreuses étapes. La première étape est une étape de criblage pharmacologique, permettant de vérifier les propriétés pharmacologiques du médicament testé. Le médicament est ensuite testé sur des animaux en phase pré-clinique. Finalement le médicament est testé sur des humains, à travers trois phases cliniques successives, au cours desquelles la dose, et l'effectif, augmentent. On considère qu'il s'agit d'une méthode scientifique car elle permet une "mesure statistique" (l.18), en "comparant ses effets à ceux d'un placebo" (l.19). Un placebo est une substance sans principe actif, substituée à un médicament pour tester la participation psychologique du patient. Ainsi, ni le patient ni le médecin ne sait si le médicament ou le placebo est administré, on parle de double-aveugle. Les médicaments sont répartis aléatoirement, il s'agit de randomisation. L'objectif principal de l'essai clinique randomisé est double : s'assurer de l'efficacité et de la sécurité du médicament. Cela permet alors d'obtenir des statistiques fiables et rigoureuses, évitant un certain nombre de biais, à propos d'un médicament. On parle alors du mouvement de l'Evidence Based Medicine, ou la médecine des preuves, elle est définie comme l'utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse de la meilleure décision de soin d'un patient. On peut considérer cela comme l'accomplissement de la recherche d'un contrôle rigoureux et scientifique des médicaments.

En conclusion, le développement et la scientifisation du contrôle des médicaments fût croissant, et fût motivé par divers évènements successifs. La découverte de l'ambivalence des substances, l'essor des spécialités, l'industrialisation, la profonde transformation du système économique pharmaceutique et les scandales sanitaires ont notamment participé aux prises de conscience successives. L'essai clinique randomisé apparaît aujourd'hui comme étant le modèle de contrôle le plus rigoureux et adéquat.
Proposition d'ouverture n°1 : Pour autant, la science est en perpétuelle évolution, et l'essai clinique randomisé, bien que modèle de référence, pourrait être amené à évoluer au cours des prochaines années. On peut notamment se poser des questions quant à l'évolution du cadre éthique des essais cliniques randomisés.
Proposition d'ouverture n°2 : Cependant, on peut se demander si nous avons réellement atteint le modèle le plus souhaitable en termes de contrôle des médicaments. En effet, dans quelle mesure certains biais systémiques, issus de questions culturelles et sociologiques, ancrés également dans les démarches de recherche, pourraient nuire à l'objectivité et la rigueur de l'essai clinique randomisé ? Ces biais, conscientisés par la population, pourraient également nuire à la confiance accordée à la recherche et au contrôle pharmaceutique. On peut notamment penser à la pilule contraceptive qui génère de nombreux débats sociétaux, notamment concernant le réel caractère favorable de sa balance bénéfice/risque.

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :
Gabrielle CHAPELAIN (DFGSM2, RM EB SHS 2026-2027), Diana ALAMI (L.AS 2 SIAS)

Relecteurs :
Gabrielle CHAPELAIN (DFGSM2, RM EB SHS 2026-2027), Orlane ABDOUL-AZIZ ZOA (DFGSM2, RM GT SHS 2026-2027), Ron SHAFIR (L.AS 2 Sciences Biomédicales), Benjamin PLASSART (DFGSM3, RM EB SHS 2025-2026)

Convertisseurs LaTeX :
Gabrielle CHAPELAIN (DFGSM2, RM EB SHS 2026-2027)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Massiva ADRAR (DFGSP2) et Alicia ZHANG (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team SixHSeven**

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Gabrielle CHAPELAIN (DFGSM2, RM EB SHS 2026-2027) et Orlane ABDOUL-AZIZ ZOA (DFGSM2, RM GT SHS 2026-2027)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP